Série temporelle des nouveaux cas de MVE en RDC

Rapport n°1 – Publié le 30 mai 2026 - Données arrêtées au 27 mai 2026

Rapport préparé par Epicentre – Unité Data Science
Henry, Erica, Maeleen, Hugo et Anton
Contact : anton.camacho@epicentre.msf.org

Résumé exécutif

- Ce rapport présente le nombre quotidien de nouveaux cas suspects et confirmés de MVE en RDC par date de notification, en complément du tableau de bord Epicentre, qui n'affiche actuellement que les totaux cumulatifs les plus récents.
- La plupart des cas signalés à ce jour se situent en Ituri, en particulier à Mongbalu, Bunia et Rwampara, tandis que les autres provinces et zones de santé ont signalé moins de cas et de manière plus sporadique.
- La série temporelle a été reconstituée à partir de trois sources : des données harmonisées compilées par Epicentre jusqu'au 25 mai, des données officielles de l'INSP à partir du 26 mai, et certaines mises à jour non officielles utilisées pour améliorer la complétude en temps-réel.
- Les écarts récents entre le nombre élevé de cas suspects et le nombre plus faible de cas confirmés reflètent probablement des retards ou des lacunes dans les tests de laboratoire et la notification, plutôt qu'une véritable baisse de la transmission.
- Comme les données du début de l'épidémie ont été incomplètes et parfois incohérentes selon les sources, ces estimations doivent être interprétées avec prudence, en particulier pour les premiers jours de l'épidémie.

Méthode

Depuis la déclaration de la 17e épidémie d'Ebola en RDC le 15 mai, des sitreps provenant de multiples sources (INSP, OMS, MSF) et sous différents formats ont été publiés. Ces rapports ont parfois présenté des chiffres incomplets ou contradictoires, entre les sources ou bien d'un jour à l'autre. Cela reflète les difficultés à mettre en place un système de gestion des données fiable au début d'une épidémie. La situation s'est améliorée avec la publication quotidienne des sitreps de l'INSP et la mise à disposition de données brutes agrégées au format CSV via le dépôt GitHub de l'INSP.

Pour reconstituer la série chronologique quotidienne, nous avons combiné trois sources de données :

1. **Données harmonisées (jusqu'au 25 mai)** - Données numérisées manuellement à partir de plusieurs sources (INSP, OMS et MSF) puis harmonisées par l'unité Data Science d'Epicentre. Lorsque c'était possible, nous avons utilisé les nouveaux cas rapportés ; sinon, nous avons calculé les nombres quotidiens à partir des variations des totaux cumulatifs. Nous avons parfois dû faire des choix arbitraires lorsque plusieurs options étaient possibles ; c'est pourquoi ces estimations doivent être interprétées avec prudence, en particulier pour les cas suspects (voir note ci-dessous).
2. **Données de l'INSP (à partir du 26 mai)** - Données officielles des sitreps de l'INSP accessibles via le dépôt GitHub de l'INSP. Dans certains cas, le dépôt fournit des informations plus complètes que les rapports eux-mêmes. Par exemple, le sitrep n°12 rapportait 16 cas confirmés sans en préciser l'origine, alors que cette information était disponible dans les données sur GitHub.
3. **Sources non officielles** - Données partagées directement avec MSF par des canaux non officiels. Celles-ci incluent des nouveaux cas signalés un jour avant leur apparition dans le sitrep de l'INSP, ainsi que deux cas confirmés au Sud-Kivu le 26 mai qui ne sont pas mentionnés dans le dernier sitrep de l'INSP (n°13).

Par souci de transparence, la série temporelle identifie la source de chaque point de donnée. À mesure que le système de gestion des donnés continue de s'améliorer, nous prévoyons de nous appuyer de plus en plus sur le dépôt GitHub de l'INSP comme source principale, complétée par des mises à jour non officielles en temps réel lorsqu'elles sont disponibles.

Définitions (de la DPS Ituri)

Alerte :

Toute personne présentant au moins deux des signes suivants (la Fièvre, courbature, céphalée, asthénie physique, douleur abdominale, vomissement).

Cas suspect :

Toute personne présentant au moins trois des signes suivant (la Fièvre, courbature, céphalée, asthénie physique, douleur abdominale, vomissement) avec notion de lien épidémiologique.

Tout cas présentant une fièvre et avec un syndrome hémorragique (épistaxis, hématémèse, hémorragie génitale ...

Cas probable : Toute personne décédée avec fièvre et hémorragie.
[À noter que la plupart des sitreps de l'INSP ne rapportent pas les cas probables. Les décès sont généralement rapportés comme suspects ou confirmés. En conséquence, nous n'intégrons pas les cas probables pour le moment.]

Note sur le statut des cas

Pour comprendre les graphiques ci-dessous, il est utile de savoir comment les cas sont classés. Lorsqu'une personne est signalée (alerte) et répond à la définition d'un cas suspect, elle est ajoutée aux nouveaux cas suspects de ce jour-là (J1). Un prélèvement est ensuite effectué et testé au laboratoire. Lorsque le résultat est disponible (au jour J2 > J1), la personne est reclassée soit comme cas confirmé, soit comme non-cas, et retirée de la liste des suspects. C'est pourquoi le nombre total de cas confirmés doit continuer à augmenter, tandis que le nombre total de cas suspects peut parfois diminuer si davantage de personnes sont reclassées comme non-cas que de nouveaux suspects ne sont signalés un jour donné.

Les nouveaux cas suspects et les nouveaux cas confirmés doivent être interprétés différemment. Le nombre de nouveaux cas suspects signalés au jour J1 ne change pas après la disponibilité des résultats de test au jour J2, car les données agrégées ne peuvent pas être mises à jour rétrospectivement. En conséquence, ce nombre indique surtout combien de résultats de tests sont attendus dans les jours suivants la notification, plutôt que combien de personnes sont encore en attente de test au moment présent. À l'inverse, les nouveaux cas confirmés signalés un jour donné correspondent à des personnes dont le diagnostic a été confirmé ce jour-là, et ce statut ne changera pas. En résumé, « suspect » est un statut temporaire (en supposant que les tests de laboratoire soient disponibles), tandis que « confirmé » est définitif. En conséquence, le nombre cumulatif des nouveaux cas suspects quotidiens est supérieur au total actuel des cas suspects, alors que le nombre cumulatif des nouveaux cas confirmés quotidiens correspond au total actuel des cas confirmés.

Nouveaux cas quotidiens par province

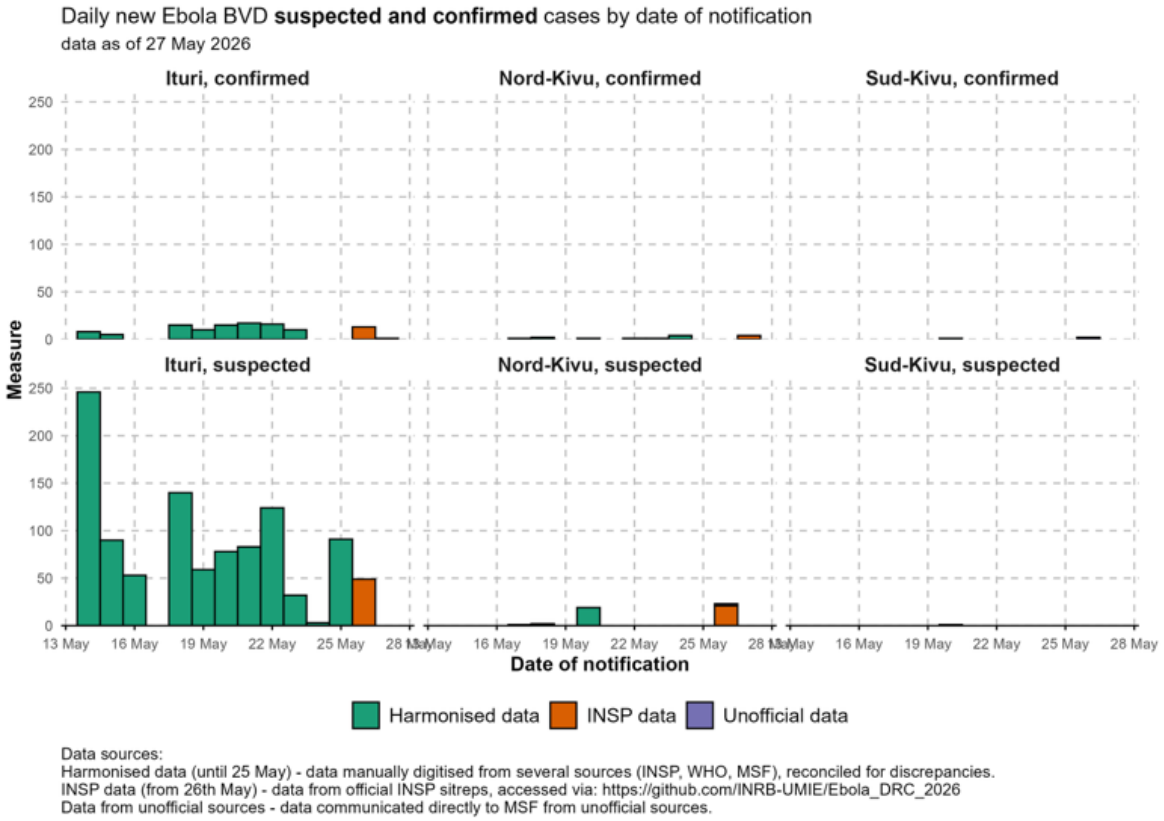


Figure 1 Nouveaux cas quotidiens confirmés (panneaux supérieurs) et suspects (panneaux inférieurs) en Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu, selon la source des données. Les six graphiques utilisent la même échelle sur l'axe des y, montrant que la plupart des cas quotidiens ont été signalés en Ituri. Le nombre élevé de cas suspects en Ituri le 14 mai reflète le premier signalement de cas suspects investigués rétrospectivement.

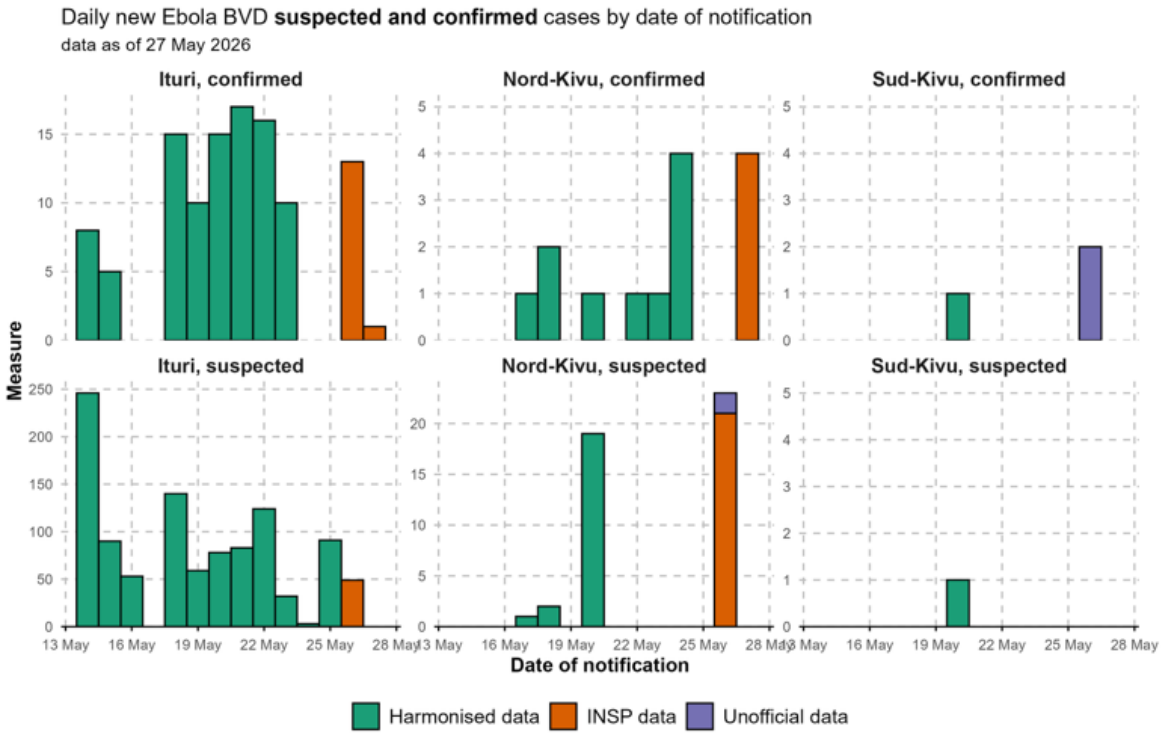


Figure 2 Identique à la Figure 1, mais avec une échelle différente sur l'axe des y pour chaque province. Cela met en évidence les deux pics de cas suspects au Nord-Kivu les 20 et 26 mai, ainsi que les deux cas confirmés signalés de manière non officielle au Sud-Kivu le 26 mai. Dans l'ensemble, l'absence récente de cas confirmés malgré le grand nombre de cas suspects reflète probablement des retards ou des lacunes dans les tests de laboratoire et la notification, plutôt qu'une véritable baisse du nombre de cas.

Nouveaux cas quotidiens par zone de santé

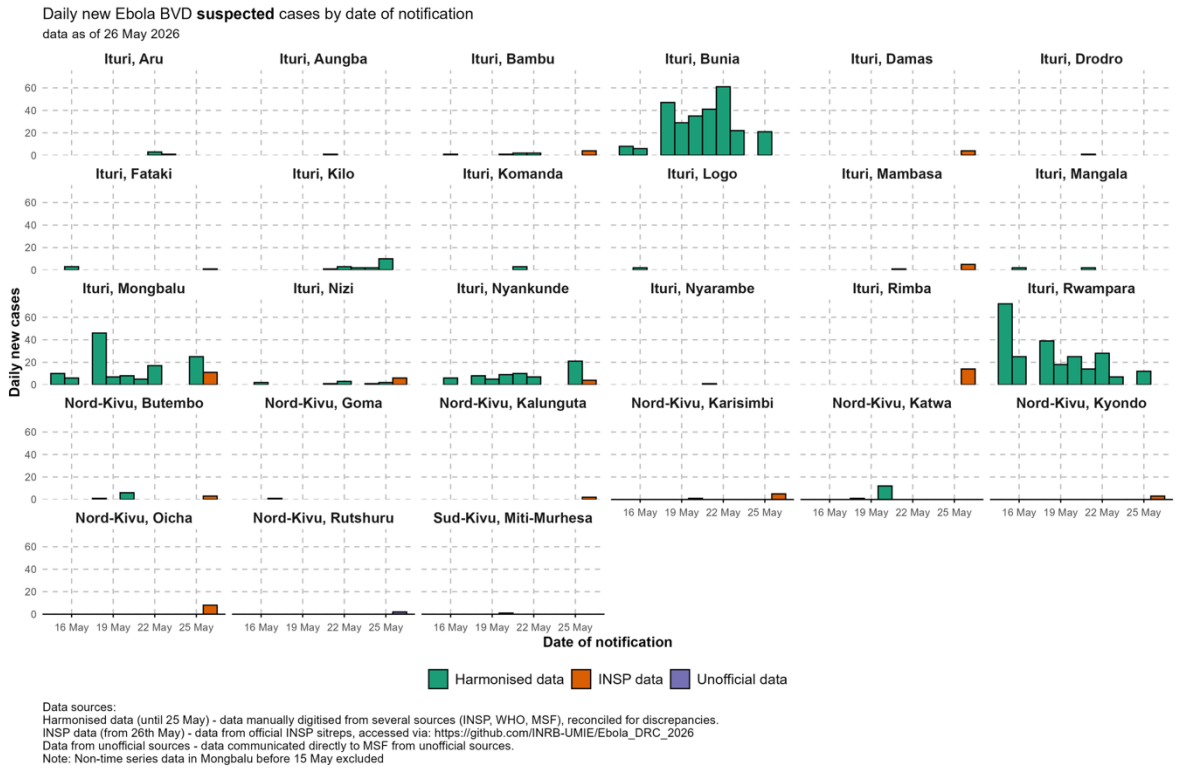


Figure 3 Nouveaux cas suspects quotidiens dans les zones de santé affectées, par source de données. Tous les graphiques utilisent la même échelle sur l'axe des y, montrant que la plupart des cas suspects ont été signalés à Mongbalu, Bunia et Rwampara. Les 246 cas suspects à Mongbalu le 14 mai sont exclus pour des raisons de lisibilité.

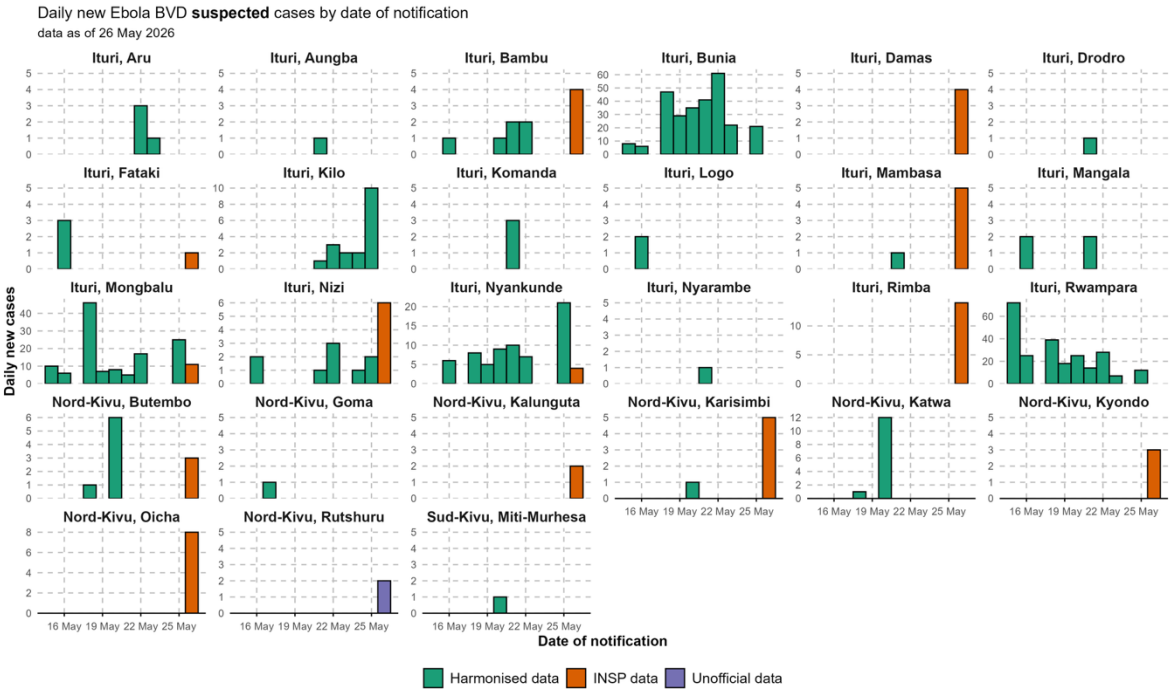


Figure 4 Identique à la Figure 3, mais avec une échelle différente sur l'axe des y pour chaque zone de santé. Cela montre que certaines zones de santé n'ont signalé que des cas suspects sporadiques, tandis que d'autres ont rapporté un nombre régulier de cas.

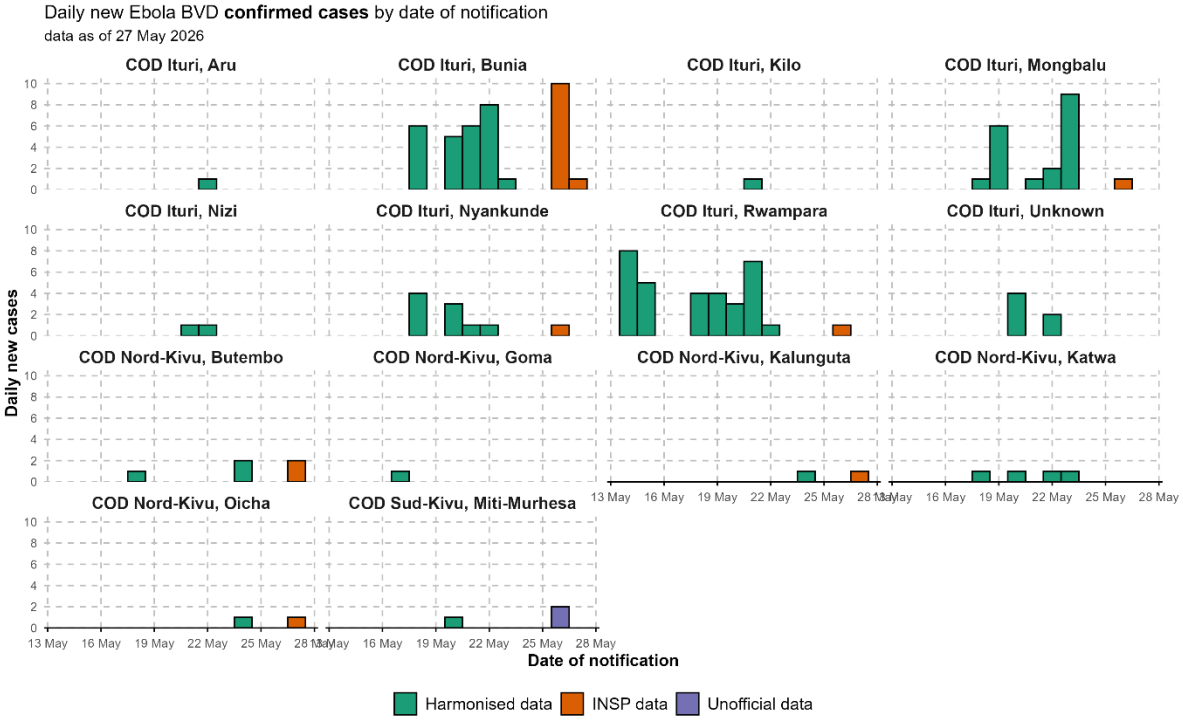


Figure 5 Identique à la Figure 4, mais en se concentrant uniquement sur les cas confirmés. En dehors de Bunia, peu de cas confirmés ont été signalés ces derniers jours dans les autres zones de santé, ce qui reflète probablement des

retards ou des lacunes dans les tests de laboratoire plutôt qu'une véritable baisse du nombre de cas. À noter également les deux cas confirmés signalés de manière non officielle à Miti-Murhesa (Sud-Kivu) le 26 mai.